KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

IHRE GESUNDHEIT STEHT BEI UNS IM MITTELPUNKT. DAFÜR SETZEN WIR UNS TÄGLICH EIN. ALS GRÖSSTES MEDIZINISCHES NETZWERK DER SCHWEIZ SIND WIR FÜHREND IN DER SPEZIALÄRZTLICHEN MEDIZIN, RADIOLOGIE UND DIAGNOSTIK.
MIT UNSEREN KLINIKEN, NOTFALLSTATIONEN, AMBULANTEN OPERATIONSZENTREN SOWIE UNSEREN RADIOLOGIE- UND RADIOTHERAPIEINSTITUTEN SIND WIR IMMER FÜR SIE DA.

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

WWW.HIRSLANDEN.CH/STANDORTE

FOLGEN SIE UNS AUF

KLINIK FÜR ANÄSTHESIE, INTENSIVMEDIZIN UND SCHMERZTHERAPIE
ST. ANNA-STRASSE 32
6006 LUZERN
T +41 41 208 33 88
KAIS@HIRSLANDEN.CH

ST. ANNA IN MEGGEN
HUOBMATTSTRASSE 9
6045 MEGGEN
T +41 41 379 60 00

ST. ANNA IM BAHNHOF
ZENTRALSTRASSE 1
6003 LUZERN
T +41 41 556 61 61

WWW.HIRSLANDEN.CH/STANNA

1214711043 50 08/26 DS KROMER PRINT AG

KLINIK ST. ANNA
ST. ANNA IN MEGGEN
ST. ANNA IM BAHNHOF

HIRSLANDEN

PRÄOPERATIVE INFORMATIONEN FÜR HAUSÄRZTE UND BELEGÄRZTE

DIESE BROSCHÜRE INFORMIERT UNSERE HAUS- UND BELEGÄRZTE ÜBER ERFORDERLICHE PRÄOPERATIVE ABKLÄRUNGEN, DEN PERIOPERATIVEN UMGANG MIT GERINNUNGSHEMMENDEN SUBSTANZEN UND THERAPIEMÖGLICHKEITEN DER PRÄOPERATIVEN ANÄMIE.



INHALTSVERZEICHNIS

4 Gründe für präoperative Abklärungen

5 Präoperative Abklärung

6 Erforderliche präoperative Abklärungen

8/9 Welche Befunde sind notwendig?

10 Umgang mit gerinnungshemmenden Medikamenten

11 Patient Blood Management (PBM)

12 Leitfaden präoperatives Management der Anämie

13 Patient Blood Management-Algorithmus

14 Behandlungsmöglichkeiten der Anämie
Indikationen und Risiken

15 Administrativer Ablauf – Befundübermittlung

15 Anästhesiesprechstunde – Kontakt

16/17 Unser Anästhesieteam

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege

Bei Ihrer Patientin oder Ihrem Patienten ist eine Operation mit Anästhesiebeteiligung geplant.

Mit Ihren präoperativen Abklärungen unterstützen Sie uns bei der sicheren perioperativen Betreuung. Aufgrund Ihrer Abklärungen können bei Bedarf rechtzeitig weitere notwendige Vorbereitungen oder Therapien veranlasst werden.

Die notwendigen Untersuchungsschritte bei Ihrer Patientin oder Ihrem Patienten haben wir für Sie in dieser Broschüre zusammengestellt. Ausserdem finden Sie in dieser Broschüre Empfehlungen zum Umgang mit gerinnungshemmenden Medikamenten und Informationen zum Patient Blood Management (PBM).

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit zu Gunsten unserer Patientinnen und Patienten.

Ihr Anästhesieteam der Klinik St. Anna, des St. Anna in Meggen und des St. Anna im Bahnhof.

GRÜNDE FÜR PRÄOPERATIVE ABKLÄRUNGEN

Die anästhesieassoziierte Sterblichkeit konnte seit Mitte des letzten Jahrhunderts von 0.064% auf aktuell 0.00047–0.00082% gesenkt werden. Die perioperative Mortalität ist immer noch deutlich höher bei 0.4-0.8%. 40 bis 50% dieser perioperativen Todesfälle werden durch kardiovaskuläre Ereignisse verursacht.

Das Risiko für perioperative Komplikationen und Mortalität ist stark assoziiert mit folgenden Nebendiagnosen:

- Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, Arithmien
- Respiratorische Partial- und Globalinsuffizienz (z.B. bei COPD)
- Anämie
- Morbide Adipositas
- Niereninsuffizienz
- Leberzirrhose
- Glykämische Variabilität
- Infektion mit multiresistenten Keimen

Ihre wertvollen Informationen über relevante «Nebendiagnosen» helfen uns, das intraoperative Anästhesiemanagement und die postoperative Überwachung sorgfältig zu planen. Damit helfen Sie uns, mögliche Komplikationen zu vermeiden oder frühzeitig zu erkennen und zu therapieren, bevor sie zu bleibenden Schäden oder gar zum Tod der Patientin oder des Patienten führen.

Insbesondere bei einer präoperativ bestehenden Anämie gibt es in der Zwischenzeit immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, dass eine Behandlung der Anämie zu einer deutlichen Reduktion der Morbidität und Mortalität führt. Hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen und werden Ihnen den Sachverhalt unter der Rubrik Patient Blood Management (Seite 11) gerne weiter erläutern.

PRÄOPERATIVE ABKLÄRUNG

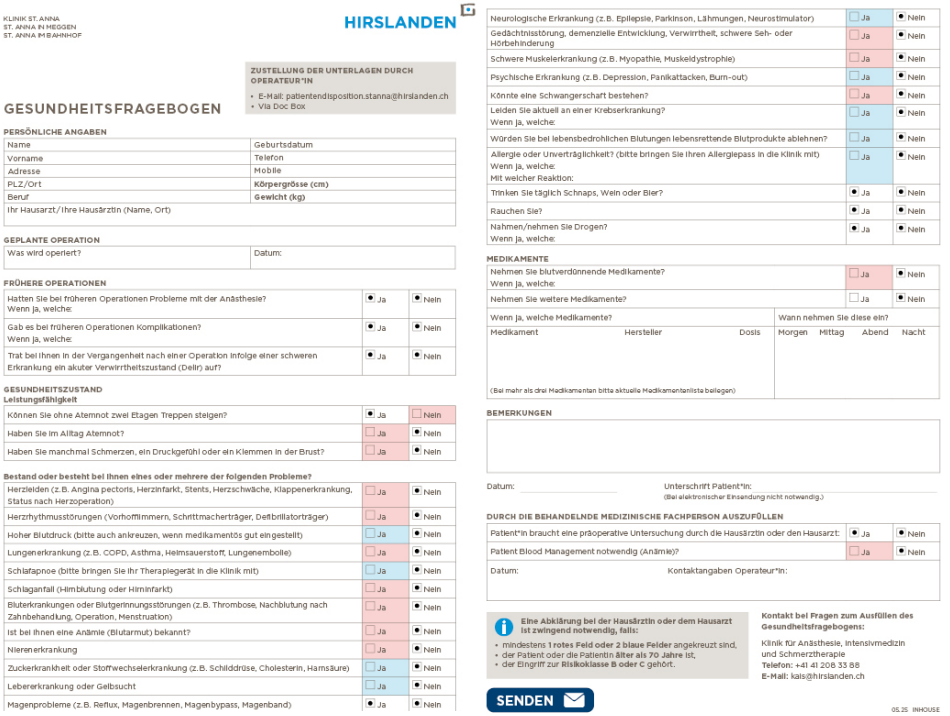
Alle Patientinnen und Patienten, bei denen ein operativer Eingriff geplant ist, erhalten vom Operateur den unten abgebildeten Gesundheitsfragebogen. Aus diesem geht anhand von roten und blauen Feldern hervor, ob eine weiterführende Abklärung durch den Hausarzt notwendig ist.

Wann ist eine Hausarztabklärung notwendig?

- Wenn im Gesundheitsfragebogen für Patienten mindestens ein Kreuz in ein rotes oder zwei Kreuze in ein blaues Feld gesetzt werden.
- bei Eingriffen der Risikokategorien B und C (vgl. Tabelle auf Seite 6)
- bei Patientinnen und Patienten, die älter als 70 Jahre alt sind

Falls möglich, sollten die Abklärungen vier Wochen vor dem Operationstermin stattfinden, um gegebenenfalls ausreichend Zeit für weitere präoperative Abklärungen oder die Behandlung einer präoperativen Anämie zu haben.

Grundsätzlich gilt: je gesünder die Patientin oder der Patient und je kleiner die Operation, desto weniger Vorabklärungen sind erforderlich.



KLINIK ST. ANNA
ST. ANNA IN HEGGEN
ST. ANNA IM BAHNHOF

HIRSLANDEN

ZUSTELLUNG DER UNTERLAGEN DURCH OPERATEUR*IN
- E-Mail: patientendisposition.stanna@hirslanden.ch
- Via Doc Box

GESUNDHEITSFRAGEBOGEN

PERSÖNLICHE ANGABEN

Name	Geburtsdatum
Vorname	Telefon
Adresse	Mobile
PLZ/Ort	Körpergrösse (cm)
Beruf	Gewicht (kg)
Ihr Hausarzt/Ihre Hausärztin (Name, Ort)	

GEPLANTE OPERATION

Was wird operiert?	Datum:

FRÜHERE OPERATIONEN

Hatten Sie bei früheren Operationen Probleme mit der Anästhesie? Wenn ja, welche:	◉ Ja	◉ Nein
Gab es bei früheren Operationen Komplikationen? Wenn ja, welche:	◉ Ja	◉ Nein
Trat bei Ihnen in der Vergangenheit nach einer Operation infolge einer schweren Erkrankung ein akuter Verwirrtheitszustand (Delir) auf?	◉ Ja	◉ Nein

GESUNDHEITSZUSTAND
Leistungsfähigkeit

Können Sie ohne Atemnot zwei Etagen Treppen steigen?	◉ Ja	☐ Nein
Haben Sie im Alltag Atemnot?	☐ Ja	◉ Nein
Haben Sie manchmal Schmerzen, ein Druckgefühl oder ein Klemmen in der Brust?	☐ Ja	◉ Nein

Bestand oder besteht bei Ihnen eines oder mehrere der folgenden Probleme?

Herzleiden (z.B. Angina pectoris, Herzinfarkt, Stents, Herzschwäche, Klappenerkrankung, Status nach Herzoperation)	☐ Ja	◉ Nein
Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern, Schrittmacherträger, Defibrillatorträger)	☐ Ja	◉ Nein
Hoher Blutdruck (bitte auch ankreuzen, wenn medikamentös gut eingestellt)	☐ Ja	◉ Nein
Lungenerkrankung (z.B. COPD, Asthma, Heimsauerstoff, Lungenembolie)	☐ Ja	◉ Nein
Schlafapnoe (bitte bringen Sie Ihr Therapiegerät in die Klinik mit)	☐ Ja	◉ Nein
Schlaganfall (Himblutung oder Hirninfarkt)	☐ Ja	◉ Nein
Bluterkrankungen oder Blutgerinnungsstörungen (z.B. Thrombose, Nachblutung nach Zahnbehandlung, Operation, Menstruation)	☐ Ja	◉ Nein
Ist bei Ihnen eine Anämie (Blutarmut) bekannt?	☐ Ja	◉ Nein
Nierenerkrankung	☐ Ja	◉ Nein
Zuckerkrankheit oder Stoffwechselerkrankung (z.B. Schilddrüse, Cholesterin, Harnsäure)	☐ Ja	◉ Nein
Lebererkrankung oder Gelbsucht	☐ Ja	◉ Nein
Magenprobleme (z.B. Reflux, Magenbrennen, Magenbypass, Magenband)	◉ Ja	◉ Nein

Neurologische Erkrankung (z.B. Epilepsie, Parkinson, Lähmungen, Neurostimulator)	☐ Ja	◉ Nein
Gedächtnisstörung, demenzielle Entwicklung, Verwirrtheit, schwere Seh- oder Hörbehinderung	☐ Ja	◉ Nein
Schwere Muskelerkrankung (z.B. Myopathie, Muskeldystrophie)	☐ Ja	◉ Nein
Psychische Erkrankung (z.B. Depression, Panikattacken, Burn-out)	☐ Ja	◉ Nein
Könnte eine Schwangerschaft bestehen?	☐ Ja	◉ Nein
Leiden Sie aktuell an einer Krebserkrankung? Wenn ja, welche:	☐ Ja	◉ Nein
Würden Sie bei lebensbedrohlichen Blutungen lebensrettende Blutprodukte ablehnen?	☐ Ja	◉ Nein
Allergie oder Unverträglichkeit? (bitte bringen Sie ihren Allergiepass in die Klinik mit) Wenn ja, welche: Mit welcher Reaktion:	☐ Ja	◉ Nein
Trinken Sie täglich Schnaps, Wein oder Bier?	◉ Ja	◉ Nein
Rauchen Sie?	◉ Ja	◉ Nein
Nahmen/nehmen Sie Drogen? Wenn ja, welche:	◉ Ja	◉ Nein

MEDIKAMENTE

Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente? Wenn ja, welche:	☐ Ja	◉ Nein
Nehmen Sie weitere Medikamente?	☐ Ja	◉ Nein

Wenn ja, welche Medikamente?				Wann nehmen Sie diese ein?			
Medikament	Hersteller	Dosis		Morgen	Mittag	Abend	Nacht
(Bei mehr als drei Medikamenten bitte aktuelle Medikamentenliste beilegen)							

BEMERKUNGEN

Datum: Unterschrift Patient*in: (Bei elektronischer Einsendung nicht notwendig.)

DURCH DIE BEHANDELNDE MEDIZINISCHE FACHPERSON AUSZUFÜLLEN

Patient*in braucht eine präoperative Untersuchung durch die Hausärztin oder den Hausarzt:	◉ Ja	◉ Nein
Patient Blood Management notwendig (Anämie)?	☐ Ja	◉ Nein

Datum: Kontaktangaben Operateur*in:

Eine Abklärung bei der Hausärztin oder dem Hausarzt ist zwingend notwendig, falls:
- mindestens 1 rotes Feld oder 2 blaue Felder angekreuzt sind,
- der Patient oder die Patientin älter als 70 Jahre ist,
- der Eingriff zur Risikoklasse B oder C gehört.

Kontakt bei Fragen zum Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens:
Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
Telefon: +41 41 208 33 88
E-Mail: kais@hirslanden.ch

SENDEN

05.25 INHOUSE

ERFORDERLICHE PRÄOPERATIVE ABKLÄRUNGEN

Aus der Tabelle auf den Seiten 8 und 9 können Sie die notwendigen präoperativen Abklärungen entnehmen. Sie benötigen hierfür die Risikokategorie der geplanten Operation, welche sich anhand der unten stehenden Beispieloperationen abschätzen lässt.

Beispieleingriffe zum operativen Risiko (modifiziert nach ESC/ESA Guidelines & DGAI)

Niedriges Risiko A (<1 %)*	Mittleres Risiko B (1–5 %)*	Hohes Risiko C (>5 %)*
Oberflächliche Eingriffe Plastisch-rekonstruktive Eingriffe Mammachirurgie	Grössere viscerale Eingriffe, (Darmresektion, Cholecystektomie, Appendektomie, Splenektomie, Hiatushernie, Hämorrhoiden- OP)	Duodeno-Pankreatektomie Leber- und Gallengangschirurgie, OP bei Darmperforation
Carotis-Chirurgie (Patient ohne neurologische Symptome)	Carotis-Chirurgie (Patienten mit neurologischen Symptomen) Aortenchirurgie endovaskulär	Aorten- oder grosse arterielle Gefässeingriffe
Augen-Chirurgie Zahnextraktionen	Operationen im Kopf-Hals-Bereich	
Kleinere orthopädische Operationen (Bsp. KAS, Meniscus-, Hand- und Fusseingriffe)	Grosse orthopädische Operationen (Bsp. Operation/ Endoprothetik an grossen Röhrenknochen/Gelenken, Rückenchirurgie)	
Kleine urologische Eingriffe (Bsp. TUR-P, TUR-B)	Grosse urologische Eingriffe (Bsp. Prostatektomie offen oder Da Vinci, Nierenresektionen)	Totale Zystektomie
Kleinere gynäkologische Eingriffe (Bsp. Hysteroskopie, Curettage)	Grosse, gynäkologische Eingriffe (Bsp. Hysterektomie abdominal)	
	Kleine intrathorakale Eingriffe	Grosse intrathorakale Eingriffe (Bsp. Pneumonektomie)

*Risiko für kardiovaskulären Tod, resp. Myokardinfarkt innerhalb von 30 Tagen nach Operation



WELCHE BEFUNDE SIND NOTWENDIG?

Modifiziert nach ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery; SGAR

	OPERATIONS-RISIKO-KONSTELLATION												ERKRANKTE ORGANSYSTEME						
Operations-Risikoklassen	A (niedriges OP-Risiko)				B (mittleres OP-Risiko)				C (hohes OP-Risiko)				Limitierende Lungenerkrankung	Kardiovaskuläre Erkrankung	Nierenerkrankung	Lebererkrankung	Strahlen- oder Chemotherapie thorakaler Organe	Diabetes mellitus	Gerinnungsstörung, Thrombose, Embolie
MET*	MET >4		MET ≤4		MET >4		MET ≤4		MET >4		MET ≤4								
Klinische Risikofaktoren**	0	≥ 1	0	≥ 1	0	≥ 1	0	≥ 1	0	≥ 1	1–2	≥ 3							
Abklärungen																			
EKG		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x		x	x		
Thorax-Röntgen								x***	x***	x***	x	x	x	x***			x***		
Standard-Labor****		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spezielles Labor																ASAT/ ALAT		HbA1c	Gerin-nung
Zusatz-Untersuchung								Ergo-metrie			Ruhe-Echo	Stress-Echo	Lufu						
Hausarzt-Bericht	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*	MET (Metabolic equivalent = Grundumsatz in Ruhe): 4 MET (2 Treppenstockwerke steigen, normale Hausarbeit)
**	Klinische Risikofaktoren: Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Stroke/TIA, Niereninsuffizienz (GFR<60 ml/min), insulinpflichtiger Diabetes mellitus
***	Thorax-Röntgen nur bei Verdacht auf Pneumonie, Atelektase, Erguss, unbekannte pulmonale Pathologie, neu aufgetretene pulmonale Symptomatik
****	Hämoglobin, Thrombozytenzahl, Quick, Natrium, Kalium, Kreatinin, Glucose, CRP

UMGANG MIT GERINNUNGSHEMMENDEN MEDIKAMENTEN

Die Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die am häufigsten verwendeten gerinnungshemmenden Medikamente. Neben den chirurgischen Blutungskomplikationen ist die Therapie mit gerinnungshemmenden Medikamenten häufig auch eine Kontraindikation für das Durchführen einer Regionalanästhesie. Insbesondere bei den zentralen Regionalanästhesien wie der Spinal- oder Periduralanästhesie erhöht sich dadurch das Risiko einer Paraplegie, welche durch ein peridurales Hämatom verursacht werden kann.

Medikament	Dosis	Absetzen vor der Operation	Präoperative Pause	Bemerkungen
LMWH				
LMWH (z.B. Fragmin)	Prophylaxe	Alle Risikoklassen	12 h	
LMWH (z.B. Fragmin)	Therapie	Alle Risikoklassen	>24 h	
Vitamin-K-Antagonisten				
Phenprocoumon (Marcoumar®) Acenocoumarol (Sintrom®)	n. Quick/ INR	• Alle Risikoklassen, ausser: • Eingriffe in der vorderen Augenkammer • Endoskopien • Kleine orale Chirurgie	8 Tage	Bridging gemäss der Empfehlung auf unserer Homepage
Direkte orale Antikoagulanzien (DOAC)				**Kein Bridging erforderlich Cave: Niereninsuffizienz**
Rivaroxaban (Xarelto®)	≤ 10 mg	Alle Risikoklassen	≥48 h	
	15–20 mg	Risikoklassen A und B	≥48 h	
Apixaban (Eliquis®)	2,5–10 mg	Alle Risikoklassen	≥48 h	
Dabigatran (Pradaxa®)	110–150 mg	Kreatinin-Clearance >80 ml/min	>48 h	
		Kreatinin-Clearance 50–80 ml/min	>72 h	
		Kreatinin-Clearance <50 ml/min	>96 h	
		Kreatinin-Clearance <30 ml/min	>120 h	
Edoxaban (Lixiana®)	30–60 mg	Alle Risikoklassen	≥48 h	
Thrombozyten-Aggregationshemmer				
Acetylsalicylsäure (Aspirin®)	100 mg	Prophylaktisch Therapeutisch	5 Tage Beibehalten, nur bei Anordnung des Operateurs pausieren	Regionalanästhesie unter laufender Therapie möglich
Analgetika wie z.B. Aspégic®	>100 mg		7 Tage	
Clopidogrel (Plavix®)	75 mg	Alle Risikoklassen	7 Tage	
Ticagrelor (Brilique®)	90 mg	Alle Risikoklassen	5 Tage	
Prasugrel (Efient®)	10 mg	Alle Risikoklassen	7 Tage	

PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PBM)

Das Patient Blood Management ist Evidence Based Medicine. Es gibt viele Studien und Metaanalysen, welche seinen Nutzen belegen und zwar in vielerlei Hinsicht.

Die präoperative Anämie ist ein unabhängiger Voraussagewert für ein perioperativ erhöhtes Infekt- und Thromboembolierisiko, eine erhöhte Mortalität und einen verlängerten Spitalaufenthalt. Damit gilt eine unbehandelte Anämie heutzutage als Kontraindikation für einen elektiven operativen Eingriff.

Das Patient Blood Management (PBM) ist ein klinisches Konzept, das patientenbezogen und interdisziplinär die Anämietherapie weg von den Fremdbluttransfusionen, hin zu einer Therapie bringt, welches die körpereigenen Ressourcen des Patienten miteinbezieht. Damit können Fremdbluttransfusionen und ihre Nebenwirkungen vermieden werden.

Das Patient Blood Management (PBM) besteht aus drei Säulen:



Um eine präoperative Therapie möglichst effizient zu gestalten, ist ein Zeitrahmen von vier Wochen ideal. Neuere Studien belegen aber auch einen Nutzen von kurzfristigen, direkt präoperativ eingeleiteten Therapien nach dem Grundsatz, dass jeder Therapietag vor dem Operationseingriff dem Patienten einen Nutzen bringt.

Patient Blood Management (PBM) erhöht damit die Patientensicherheit, vermindert Bluttransfusionen (erhöht damit die Verfügbarkeit von Blutprodukten) und vermindert die perioperative Morbidität/Mortalität. Ein wertvoller gemeinsamer Einsatz, welcher unseren Patientinnen und Patienten zu Gute kommt.

Nachfolgend finden Sie den Leitfaden zur Behandlung der präoperativen Anämie.

LEITFADEN PRÄOPERATIVES MANAGEMENT DER ANÄMIE

Ziel der präoperativen Behandlung der Anämie ist es, bei Männern und Frauen einen präoperativen Hb-Wert von 130 g/l zu erreichen. Elektive Operationen mit einem potentiellen Blutverlust von > 300 ml sollten bei Patientinnen und Patienten mit einem Hb-Wert < 130 g/l gemäss aktuellen Empfehlungen erst nach einer Abklärung und Behandlung der Anämie durchgeführt werden.

Bei folgenden Operationen (Risikoklasse B und C) sind eine Abklärung und Behandlung der Anämie bei elektiven Eingriffen indiziert:

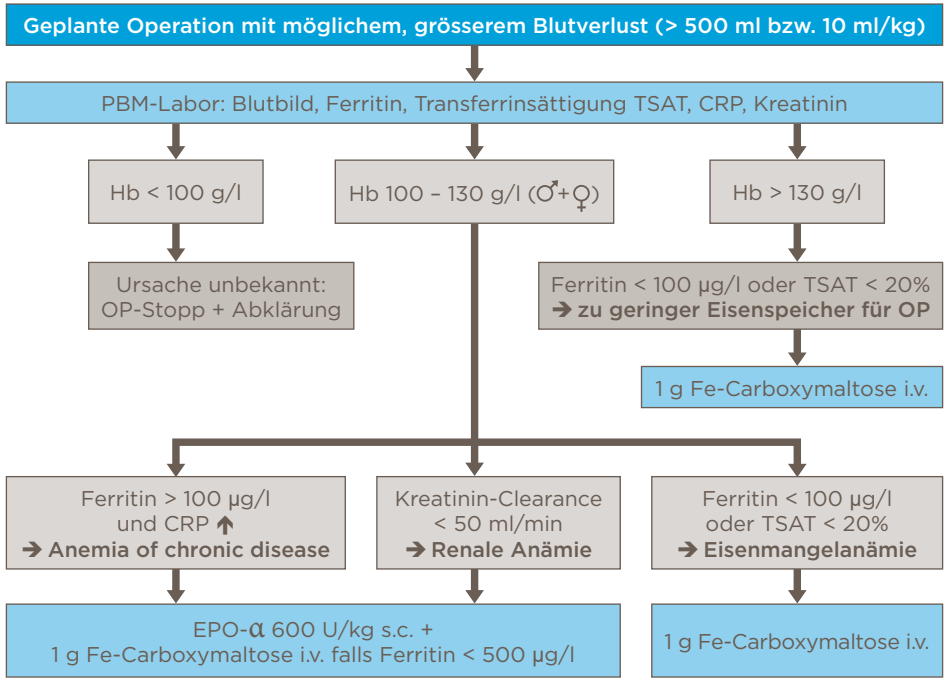
- Orthopädie: Gelenksersatz, Revisionen (Hüfte, Knie, Schulter)
- Neurochirurgie: Spondylodesen über zwei Etagen und mehr, Revisionen, Tumor-Operationen Wirbelsäule
- Gefässchirurgie: Aortenaneurysmen
- Gynäkologie: grosse abdominale, gynäkologische Operationen
- Urologie: Prostatektomien, Nephrektomien, Cystektomien
- Visceralchirurgie: Leber, Pankreas, Darm (häufig präop. Anämie)

Zeitfaktor:
Der Behandlungsbeginn der Anämie sollte ca. vier Wochen präoperativ erfolgen. Auch wenn die ideale Zeitspanne für die Behandlung der präoperativen Anämie nicht eingehalten werden kann, macht es Sinn, mit der Anämiebehandlung zu beginnen und diese anschliessend perioperativ weiterzuführen.

Laborparameter primär:	Hb, MCV, Ferritin/TSAT, CRP, Kreatinin
Laborparameter sekundär:	Retikulozyten, Vit B12 (Holo-Transcobalamin) und Folsäure bei MCV erhöht (intraerythrozytär)

Um für Sie das Patient Blood Management möglichst einheitlich zu gestalten, haben wir uns mit dem Luzerner Kantonsspital abgesprochen und verwenden gemeinsam den unten aufgeführten Algorithmus zum Patient Blood Management.

PATIENT BLOOD MANAGEMENT-ALGORITHMUS



Beachte:

- **Eisen:** Kurzinfusion über 20–30 min unter Monitorkontrolle, z.B. Ferinject® 20 mg/kg (max. 1 g pro Woche)
- **EPO-α**: 600 U/kg, z.B. 40'000 E Eprex® s.c. (max. 1 x/Woche)
- **Vit. B12** 1 mg s.c./i.m.: z.B. Vitarubin® kann gegeben werden (1–3 x, max. 1 x/Woche)
- **Folsäure** 5 mg p.o.: z.B. Acidum Folicum® kann täglich bis OP gegeben werden
- Schwangerschaftsanämie:
  1. Trimester < 110 g/l 2./3. Trimester < 105 g/l Postpartum < 100 g/l

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN DER ANÄMIE INDIKATIONEN UND RISIKEN

Medikament	Indikationen	Evidenz	Risiken	Kosten
Erythropoietin z.B. Eprex® sc.	nach Diagnostik und Bewertung der Mangelanämie bei Hb < 120 g/l Onkochirurgie/ Onkologie 110 g/l CKD (FDA Box-Warning 2011) ≤ 100 g/l • Andwendung nur in Komb. mit perioperativer TE-Prophylaxe • bei onkologischen Pat: individuelle Nutzen-Risiko-Abschätzung	Evidenz 2A	• KI: Thromboembolie in letzten 6 Mo Epilepsie in PA Hämophilien (pos Lupusantikoag.) • Thrombo-embolische Komplikationen • Tumorprogression • unkontrollierte Hypertonie	480 CHF/ 40'000 E
Eisen-Carboxymaltose z.B. iv: Ferinject®	nachgewiesener Eisenmangel • wenn die entereale Therapie kontraindiziert, nicht durchführbar oder wirkungslos • perioperativ kurzfristig (Orthopädie) • Herzchirurgie (Colorectale Chirurgie kein Nutzen)	Evidenz 1A Evidenz 2B	• Eisenüberladung • Infektsituation • Anaphylaxie (0.11%; Überwachung) • erstes SS-Trimenon • Bradykardie, BD-Anstieg, Nausea/ Erbrechen • Arthralgie-Myalgie-Syndrom (2-4 d nach Inj.) Brust-/Abdominal-/ Kopfschmerz	338 CHF/ 1000 mg
Vitamin B12 z.B. Benexol s12® po. z.B. VITAMIN B12 Amino® im.	nachgewiesener Vitamin-B12-Mangel • erhöhter Bedarf, verminderte Zufuhr (Alkoholismus, Beribei) • perniziöse Anämie, Vitamin-B12-Mangel nach Magen- oder Dünndarmresektion		• Überempfindlichkeit • Leber'sche Opticus-Atrophie • Demaskierung eines Folsäure-Mangels	ca. 1.50 CHF/ 1 mg ca. 2 CHF/ 1 mg
Folsäure z.B. Acidum Folicum® po.	Folsäure-Mangel • Fehlernährung, intestinale Erkrankung • Arzneimittel-Interaktion, Schwangerschaft • hämolytische Anämie		• Überempfindlichkeit • Erregung, Schlafstörung • epileptische Erkrankungen	ca. 2 CHF/ 5 mg

ADMINISTRATIVER ABLAUF – BEFUNDÜBERMITTLUNG

Damit der Gesundheitszustand der Patientin und des Patienten möglichst aktuell beurteilt werden kann, sollten Ihre präoperativen Untersuchungen nicht älter als zwei Monate alt sein. Herzlichen Dank für ein zeitnahes Einsenden der Unterlagen.

AUFGRUND EINER ZENTRALEN DOKUMENTENABLAGE SENDEN SIE BITTE DIE GEWÜNSCHTEN UNTERLAGEN AN:
zuweiserberichte@hirslanden.ch

ANÄSTHESIESPRECHSTUNDE

Falls eine der nachfolgenden Indikationen zutrifft, danken wir Ihnen für eine Anmeldung der Patientin oder des Patienten zu unserer Anästhesiesprechstunde:

- Patientenwunsch (beispielsweise ausgeprägte Angst)
- St. n. Narkosezwischenfall
- Schwere Begleiterkrankungen: instabile AP, schwere Herzinsuffizienz, schwere Herzklappen-Erkrankung, St. n. PTCA vor weniger als zwölf Monaten, eingeschränkte Leistungsfähigkeit NYHA III/ IV, schwere Pneumopathie, schwere Nieren- oder Leberinsuffizienz, Gerinnungsstörung, schwere neuromuskuläre Erkrankungen

Anmeldungen für die Anästhesiesprechstunde nehmen wir gerne per E-Mail entgegen: **kais@hirslanden.ch**

Trotz einer Anmeldung in die Anästhesiesprechstunde sind wir für eine präoperative Abklärung durch den Hausarzt und das Zustellen der präoperativ notwendigen Unterlagen dankbar.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
T +41 41 208 33 88
E-Mail: kais@hirslanden.ch

UNSER ANÄSTHESIETEAM

An unseren Luzerner Standorten der Klinik St. Anna erwartet Sie ein erfahrenes Team von Fachärztinnen und Fachärzten der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie.

UNSER ANÄSTHESIETEAM DER LUZERNER HIRSLANDEN-STANDORTE


med. pract.
Florian Albrecht


Dr. med.
Andreas Berger


Dr. med.
Andreas Bürgi


Dr. med.
Daniel Christ


Dr. med.
Felix Reichlin


Dr. med.
Viviane
Reul Albrecht


Dr. med.
Esther Schmid


Dr. med.
Norbert Schmitter


Dr. med.
Ramon Dörig


Dr. med.
Jörg Gysin


PD Dr. med.
Luzius Hiltebrand


Dr. med.
Matthias Hoffmann


Dr. med.
Sybille Stalder


Dr. med.
Cornelia Stocker


dipl. Arzt
Wolfgang Strnad


Dr. med.
Leona
von Schnakenburg


Dr. med.
Daniel Marfurt


Dr. med.
Hanswilly Mattes


Dr. med.
Thaddaeus
Odermatt


Dr. med.
Simone Reich


Dr. med.
Susanne Vuilleumier

MEINE NOTIZEN